リハ医療デイリー

REHA MEDICAL DAILY

2026年10月21日（水）

第40号　朝刊

きょうの紙面　▶臨床倫理・集中治療　▶心臓リハ・医療AI　▶運動療法・高血圧　▶短信 8本

■ 臨床倫理・集中治療

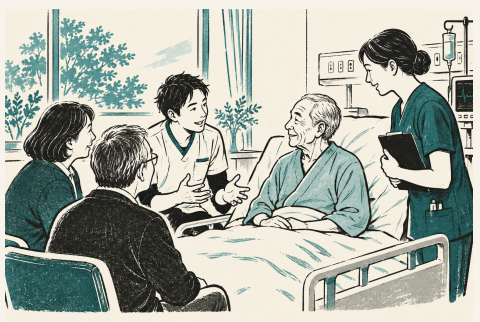
生命維持治療の終了・差し控え 4学会合同GLが12年ぶり改訂

終末期の定義は置かず、終了を検討する医療行為に身体拘束も挙げた

日本集中治療医学会、日本救急医学会、日本循環器学会、日本緩和医療学会の4学会が、「救急・集中治療における生命維持治療の終了／差し控えに関する4学会合同ガイドライン」を公表した。2014年の3学会提言から12年ぶりの改訂で、本編、緩和ケア別編、Q&A集（77問）、解説からなる。臨床倫理と意思決定支援の指針と位置づけられている。

「終末期」の定義は置かず、急性期病院で治療方針を決める患者を疾患を問わず対象にした。期限付きの治療試行（TLT）を示し、差し控えと終了は倫理的に同等と明記した。緩和ケア別編では、終了を検討する医療行為として透析や経管栄養などと並んで身体拘束が挙げられた。

Q&Aでは、障がいや医療的ケアだけを理由に終了を検討しないこと、形式だけの多職種検討をしないことを求めている。内容はPT-OT-ST.NETの解説に基づき、細部は原本での確認が要る。ICUで早期離床に関わるリハ職にとっても、拘束の見直しを考える材料になる。



終了を検討する対象に身体拘束。離床に関わる職種も当事者。

出典 日本集中治療医学会ほか／PT-OT-ST.NET ↗

数字で見る

12年ぶり
2014年の3学会提言からの改訂

4学会
集中治療・救急・循環器・緩和

77問
Q&A集の設問数

■ 心臓リハ・医療AI

心臓リハにChatGPTの個別支援 継続率91.7%対75.0%

冠動脈疾患の患者を、多職種が監督する6か月の心臓リハに、ChatGPTによる個別の支援を足した群（48例）と通常の心臓リハだけの群（48例）に分けた。継続率は91.7%対75.0%（P=0.028）、満足度は5段階で4.5対3.8。IPAQで測った身体活動量（MET）の改善もChatGPT群が大きかった。

ただし抄録に割り付け方法の記載がなく、無作為化かは確認できない。身体活動は自己申告で、ChatGPTの使い方も抄録からは分からない。支援の中身を本文で確かめたい。



出典 Turk Kardiyol Dern Ars ↗

■ 運動療法・高血圧

高血圧の運動、週2回と週4回 総量同じなら血圧変動に差なし

週の運動量は120～160分、強度は自覚的運動強度4～6で、総量と負荷のかけ方は両群でそろえた。12週後、出席率80%以上の47例（週2回27例、週4回20例）を解析した。24時間と日中の収縮期血圧の変動（ARV）は、週4回で2～3mmHg、週2回で1～2mmHg下がったが、群と時間の交互作用は有意でなかった。



出席率で絞った解析で、各群20～27例と小規模。「週2回で足りる」とは言い切れないが、通院の都合で回数を減らす相談の材料にはなる。

出典 Front Rehabil Sci ↗

短信

〈呼吸リハ〉 **呼吸リハの2026年版専門家合意**
仏語圏の専門家の立場表明。COPD以外の間質性肺疾患や肺高血圧へ適応を広げ、在宅・遠隔型も整理。
出典 Rev Mal Respir ↗

〈作業療法〉 **作業中心の実践尺度、日本語版を検証**
OT351人で検証。再検査信頼性ICC0.87、MDC95は1.94点。構造の当てはまりは混合だった。 出典 OTJR ↗

〈制度・訪問リハ〉 **診療未実施減算、算定率は11.0%に低下**
10/19の介護給付費分科会資料。創設時20.8%から低下、リハマネ加算の併算定は27.7%。 出典 PT-OT-ST.NET ↗

〈周術期〉 **肺がん術後の看護師主導プログラムRCT**
韓国76例。自己効力感が16週で約20点改善、自己管理も向上。6分間歩行・肺機能・QOLに群間差はなし。
出典 Eur J Oncol Nurs ↗

〈脳卒中〉 **脳静脈血栓症、DOACはワルファリンに非劣性**
中国2,476例の模擬試験。1年の再発VTEは3.74%対5.47%で非劣性。出血の比較は探索的。 出典 Stroke ↗

〈膝OA・肥満〉 **レタトルチド、膝OA合併で疼痛も評価**
第3相80週のRCT。膝OA合併574例でWOMAC疼痛、睡眠時無呼吸243例で無呼吸指数を評価。 出典 NEJM ↗

〈退院支援〉 **主介護者の続柄とホスピス利用・ACP**
米国の60歳以上の死亡者3,952例。主介護者が配偶者か子か他人かで、ホスピス利用とACPの違いを分析した。
出典 J Am Geriatr Soc ↗

〈認知症〉 **認知症の服薬管理、家族の負担は情報面**
カナダの家族介護者13人。負担は情報の共有・探索で最も大きく、多剤併用で最も小さい。病期に合う支援が要る。
出典 Disabil Rehabil ↗